Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Venâncio Aires

Rua Berlim da Cruz, 1306 - Bairro: Centro - CEP: 95800000 - Fone: (51) 30985597 - Email: frvaires1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001974-22.2022.8.21.0077/RS

AUTOR: JOAO ARLINDO PEREIRA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICIPIO DE MATO LEITAO / RS

SENTENÇA

Vistos, etc.

JOAO ARLINDO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ajuizou **ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada** em face do **MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO/RS e do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Alega, em síntese, que é portador da doença catalogada no **CID10 - C61 - Neoplasia Maligna da Próstata**, e, portanto, necessita fazer uso da medicação: **ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 500mg, tomar dois comprimidos, via oral, em jejum, 1 vez ao dia ou ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250mg, tomar quatro comprimidos, via oral, em jejum, 1 vez ao dia** (evento 1.1). Relatou que, conforme laudo médico anexado junto aos autos (evento 1.11), o requerente é *"é hipertenso e foi diagnosticado em janeiro de 2015 com adenocarcinoma de próstata; realizou tratamento com radioterapia associada a bloqueio hormonal com esquema Eligard até abril de 2018. Em abril de 2021 teve nova progressão bioquímica e foi associado tratamento com Bicalutamidade até novembro de 2021, quando o paciente teve progressão da doença, entretanto, devido à idade avançada não tem condições clínicas de receber tratamento quimioterápico disponível no SUS"*. Refere que a medicação necessita ser utilizada de *"forma contínua, inicialmente pelo período de 1 ano de tratamento, o qual deve ser iniciado de forma urgente, sob pena de piora do quadro clínico, progressão da doença e morte precoce"*. Salientou que o fármaco ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 500mg, pleiteado no presente feito, foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde através da Portaria conjunta MS n. 77, de 14 de dezembro de 2018 e não existe pelo SUS nenhuma medicação semelhante, bem como que o custo do tratamento durante o período de 03 (três) meses, sendo necessárias 03 (três) caixas de medicação, teriam custo aproximado de R$ 44.982,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais), conforme orçamentos anexados nos autos (evento 1.13). Requereu AJG e juntou documentos.

Deferida a tutela de urgência para determinar ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ao MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO/RS, que procedam a entrega do medicamento postulado na inicial, no prazo máximo de cinco dias, ou proceda ao depósito do valor correspondente, sob pena de bloqueio de valores, bem como deferida a AJG ao requerente (evento 3.1).

O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo de instrumento (evento 11), contra a decisão liminar, tendo sido o mesmo julgado pela 22ª Câmara Cível do TJ/RS, dando-se provimento ao recurso, apenas para que fosse reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, de forma a assegurar ao Agravado a inclusão da União, no polo passivo da lide, sob pena de extinção do processo, mantidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela antecipada (evento 63).

Após, o ente estaducal apresentou Contestação, pugnando, em síntese, fosse seja acolhida a arguição tocante ao cumprimento do tema 793, STF, determinando-se à parte autora que, em emenda à petição inicial, requeira a citação da União, tudo nos termos do art. 115, parágrafo único, CPC, sob pena de extinção do processo, em sede preliminar; posteriormente, seja os autos remetidos à Justiça Federal para processamento e julgamento, nos termos do art. 109, I, CF; no mérito, seja o pedido julgado improcedente (evento 16.1).

O autor veio aos autos informar que os entes não lhe forneceram o medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg – 04 comprimidos ao dia, desrespeitando a decisão liminar. Requereu o bloqueio de valores na conta dos requeridos, suficientes para três meses de tratamento, no valor total de R$ 43.643,22 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e três reais com vinte e dois centavos) (evento 19.1).

O Município de Mato Leitão/RS apresentou Contestação, alegando, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e requerendo sua exclusão do polo passivo da ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido (evento 21.1).

Deferido o pedido de bloqueio requerido pela parte requerente, para três meses, bem como determinada a intimação do autor para apresente Réplica às Contestações, além de intimação das partes sobre as provas que pretendiam produzir (evento 23.1).

Determinada a intimação da parte autora para que procedesse na inclusão da União, conforme decisão em agravo de instrumento, no polo passivo da ação (evento 33.1).

Feita a prestação de contas no evento 40.1.

O autor requereu a manutenção da tramitação do feito perante o Juízo Estadual, ao menos até que sobreviesse decisão transitada em julgado da Superior Instância, alegando que *"em se tratando o presente feito de ação de saúde para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, deve haver a estrita observância dos*

termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção do curso das ações na Justiça Estadual" (evento 49.1).

Apresentada Réplica rechaçou os argumentos expendidos pelos requeridos, ratificando os termos da inicial (evento 51.1).

As partes foram intimadas acerca do interesse na produção de mais provas (evento 57.1).

O Estado do Rio Grande do Sul veio aos autos pugnar pela intimaçaõ da parte autora *"para atender à determinação do evento* 33.1*, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida em grau recursal"* (evento 65.1).

O requerente veio aos autos argumentando que a *"decisão que declinou da competência foi proferida em desrespeito ao que decidiu a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 187.276, quando determinou a afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos"*, pugnando pela manutenação da tramitação dos autos poeranrte a Justiça Estadual, respeitando a decisão do STJ (evento 74.1).

Dada vista ao Ministério Público, houve manifestação no sentido de intimar a *"parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial a fim de incluir a União no polo passivo do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do processo, ficando mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º)"* (evento 79.1).

Intimada novamente, a parte requerente reforçou a tese do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 187.276 – IAC 14/STJ, pugnando pela manutenção dos autos neste juízo (evento 83.1).

O Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pelo *"o prosseguimento do feito em cumprimento à decisão proferida no AI nº 50847567520228217000, com a intimação da parte adversa para que emende a inicial a fim de incluir a União no polo passivo do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do processo, conforme já havia sido sugerido no parecer do Ministério Público juntado no evento 79.1"* (evento 89.1).

O Juízo se manifestou, afastando a inclusão da União no polo passivo da ação, mantendo a tramitação do feito perante a Justiça Estadual, determinando-se a conclusão dos autos para julgamento, haja vista as partes terem quedados inertes quanto a produção de provas (evento 93.1).

Intimado, o Ministério Públicou opinou pela *"pela procedência do pleito inicial, condenando-se o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES a fornecerem o medicamento pleiteado pelo autor, pelo prazo postulado na exordial"* (evento 99.1).

O Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se que *"apresentará sua inconformidade no momento processual oportuno pela via recursal própria após o julgamento do feito, se for o caso"* (evento 101.1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Cabível a decisão do processo no estado em que se encontra, dispensando-se a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Necessário esclarecer que é imperiosa a decisão proferida no evento 93.1. Conforme bem fundamentando, é certo que a Constituição estabelece como competência administrativa comum e solidária entre todos os entes federativos a realização do direito à saúde (art. 23, II). Com fundamento nesse preceito constitucional, bem como no que dispõem os arts. 196 e 198, o Supremo Tribunal Federal confirmou a jurisprudência já predominante sobre o tema, firmando precedente vinculante (RE 855178/2015, Tema 793) pela existência de solidariedade entre **União**, Estados e Municípios em matéria de saúde, de modo que a parte poderia mover a ação contra qualquer ou quaisquer um deles. Veja-se:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.* ***É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). – grifei.*

Dessa forma, os **entes públicos são solidariamente responsáveis em matéria de atendimento à saúde pública**, consoante já decidiu o STF:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.* ***I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.*** *II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. (AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010) (grifei)*

Além disso, o STJ, julgando em definitivo o IAC 14, fixou as seguintes teses:

> *a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes **contra os quais a parte autora elegeu demandar**;*
>
> *b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do **polo passivo** delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.*
>
> *c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no **polo passivo** da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da **União** no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)*

Em que pese o ERGS tenha argumentado que foi proferida decisão no Recurso Extraordinário nº 1.366.243 SC, relativo ao tema 1.234, ainda não há julgamento definitivo da mesma, e, portanto, prevalece a decisão proferida no IAC 14, até seu julgamento definitivo, no qual a 1ª Seção do STJ fixou a seguinte tese:

> *Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.*

Pelos mesmos fundamentos, **indefiro**, portanto, o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Mato Leitão/RS.

Todavia, não basta o reconhecimento formal do direito fundamental em tela, sendo dever implementá-lo, ante o princípio da máxima efetividade e o acesso à saúde e a vida digna prevista como fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal).

O direito à saúde é direito fundamental e impostergável tanto quanto o é o direito à vida.

A questão relativa à divisão dos custos decorrentes do cumprimento da medida judicial deverá ser solucionada na via administrativa ou em ação judicial própria, por ser estranha à lide, estabelecida apenas entre a parte autora, beneficiária do SUS, e a parte ré, o Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, **sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos e, assim considerando, não havendo a Lei Maior especificado sobre quem recairia o dever do Estado em garantir a todos os cidadãos o direito à saúde, será este dever de todos: da União, dos Estados e dos Municípios**. Precedente: STJ, AgRg no Ag 1107605/SC, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14.09.2010.

É inconteste que com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o seu devedor, pressupondo o artigo 196 da Constituição Federal a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.

Então, descumprindo o Estado este dever no papel de garantidor desse direito, abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.

Por fim, saliento que se trata de dever compartilhado por todos os entes públicos. Na verdade, a Lei n.º 8.080/1990 estabelece uma *"divisão interna"* de tarefas, devendo-se promover *"a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal"* (artigo 16, incisos XIII e XV). Aos Estados, por sua vez, incumbe (artigo 17, incisos I e III) *"promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde, e prestar-lhe apoio técnico e financeiro e executar supletivamente ações e serviços de saúde".*

Como se vê, há mera descentralização político-administrativa entre os entes de direito público interno, o que não serve de óbice para que o cidadão possa pleitear, solidariamente, de qualquer dos entes federativos, os medicamentos necessários ao seu tratamento.

Relativamente ao caso concreto, foi produzida prova documental, demonstrando a autora a necessidade do uso do medicamento postulado, o qual tem registro na ANVISA (evento 1.15).

Segundo consta no Atestado Médico (evento 1.11):

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente: João Arlindo Pereira
Diagnóstico: Adenocarcinoma de próstata
CID 10: C61

História clínica: O senhor João Arlindo Pereira, 83 anos, hipertenso, foi diagnosticada em janeiro de 2015 com adenocarcinoma de próstata localizado EC II. Realizou tratamento com radioterapia associada a bloqueio hormonal com esquema Eligard, até abril de 2018. Em julho de 2020, teve recidiva bioquímica, sendo exposto novamente a Eligard. Em abril de 2021, teve nova progressão bioquímica e foi associado tratamento com Bicalutamida até novembro de 2021, quando paciente teve progressão de doença, com o aparecimento de metástases ósseas. Paciente possui bom performance status (ECOG 1), entretanto neste momento devido à idade avançada não tem condições clínicas de receber tratamento quimioterápico (Docetaxel) disponível no SUS, devido as múltiplas comorbidades.

A história natural da neoplasia em questão, quando não tratada com terapias que possam potencialmente alterar seu prognóstico, cursa com complicações clínicas graves que incluem piora do sensório, déficit motor e cognitivo e disfunção de órgãos vitais. Há consequente aumento na procura de serviços de pronto-atendimento, incluindo o aumento de internações hospitalares (com necessidade de medidas de suporte em unidade de tratamento intensivo – UTI) e com desfecho desfavorável e elevado risco de morte.

Indicação: Visto o acima relatado, a paciente tem indicação de receber tratamento com Acetato de abiraterona (genérico ou Zytiga®). Este tratamento resulta em aumento do tempo livre de progressão (tempo para haver progressão da doença) e aumento da sobrevida global. Além disso, houve superioridade em tempo para a progressão do PSA, maior tempo para o início do uso de opióides para dor relacionada ao câncer e maior tempo para deterioração da qualidade de vida com uso de abiraterona. Este medicamento possui estudos clínicos que justificam seu uso pela eficácia, os quais podem ser acessados nas referências citadas abaixo. Não existe pelo sistema único de saúde, SUS, nenhuma outra medicação semelhante.

Medicamento solicitado: Acetato de abiraterona (genérico ou Zytiga®) Uso: 1000 mg Via Oral, uma vez ao dia, contínuo. Para fins de início, solicitamos o tratamento para 12 meses. Não existe pelo sistema único de saúde, SUS, nenhuma outra medicação semelhante.

Duração do tratamento: O tratamento não possui previsão de término. O medicamento é de uso contínuo, sendo interrompido se surgimento de efeitos colaterais não toleráveis ou progressão de doença. Para fins de início de tratamento, solicito a liberação da medicação por 12 meses.

Assim, tenho por comprovada a necessidade da utilização do medicamento postulado, bem como da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, impondo-se a procedência do pedido da autora.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação, para confirmar a tutela de urgência deferida, determinar ao Município de Venâncio Aires e ao Estado do Rio Grande do Sul, que **forneçam à parte requerente, pelo prazo indicado pelo médico da parte autora, o medicamento ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 500mg, tomar dois comprimidos, via oral, em jejum, 1 vez ao dia ou ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250mg, tomar quatro comprimidos, via oral, em jejum, 1 vez ao dia.**

Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios ao FADEP, verba que fixo em R$500,00, e metade das custas processuais. Os demandados estão isentos da taxa única, fulcro no artigo 5º, inciso I, da Lei da Taxa única, mas as despesas são devidas integralmente.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Diligências Legais.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO FRANCISCO GOULART BORGES, Juiz de Direito**, em 23/7/2024, às 15:58:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10063581641v14** e o código CRC **5e6f098b**.